

. Introducción a la Terapia Ocupacional en disfunciones del aparato locomotor I

- Terapia Ocupacional en Fracturas mas comunes
- Etiopatogenia
- intervención Terapéutica desde el enfoque Ocupacional: manejo en silla de ruedas

FRACTURA DE CLAVÍCULA

- Por caídas en extremidad superior
- Más común en tercio medio
- Fragmento medial: se desplaza posterosuperior
- Fragmento distal: se desplaza anteroinferior

Tratamiento conservador

- Vendaje en 8 de guarismo (en fx muy desplazada)
- Vendaje de Velpeau (en fx poco desplazada)

Se deja de 4-5 semanas en adulto, 2-3 semanas en niño.

Tratamiento quirúrgico indicado en: fractura abierta, lesión vascular asociada, gran desplazamiento, amenaza de la integridad de la piel, fractura de tercio distal desplazada, fractura asociada a cuello de la escápula, ausencia de consolidación, fracturas bilaterales y pacientes politraumatizados.



FRACTURA DE DIÁFISIS DE HÚMERO

Tratamiento conservador en fracturas espiroideas, oblicuas largas, anguladas y acortadas

- Vendaje de Velpeau
- Férula
- Yeso colgante de Caldwell

Tratamiento quirúrgico en fracturas transversas. Puede estar indicado en pacientes jóvenes con fractura del tercio medio del húmero y en obesidad.

- Osteosíntesis con placas y tornillos

Complicaciones

- Lesión de nervio radial: común en Fx de Holstein Lewis (tercio distal)
- Neuroapraxia que se recupera en 4 meses



FRACTURA DE HÚMERO DISTAL

FRACTURA DE PALETA HUMERAL (SUPRACONDÍLEAS O SUPRAINTERCONDÍLEAS)

- Suelen ser intraarticulares, desplazadas y de elevada conminución.
- **Tratamiento:** reducción abierta y osteosíntesis de placa lateral y medial. En niños, reducción cerrada y en ancianos artroplastia.
- **Complicaciones:** rigidez, ausencia de consolidación, artrosis postraumática y neuropatía cubital

FRACTURA DE CABEZA DEL RADIO

- Por caídas en la palma de la mano
- Hay dolor y limitación funcional del codo

Lesión de Essex-Lopresti

- Fractura conminuta de cabeza de radio + lesión de articulación radiocubital distal y la membrana interósea
Puede causar dolor crónico de la muñeca.

COMPLICACIONES: limitación de flexoextensión, inestabilidad del codo e inestabilidad longitudinal del antebrazo con migración proximal del radio.



FRACTURA DE LA DIÁFISIS DEL ANTEBRAZO

Antebrazo: diáfisis cubital y radial, articulación radiocubital proximal (RCP) y distal (RCD)

FRACTURA AISLADA DE DIÁFISIS CUBITAL

(fractura del bastonazo)

- Por golpe directo
- Escaso desplazamiento
- Antebrazo estable

Tratamiento conservador

Yeso braquioantebraquial

Yeso funcional



FRACTURA DE DIÁFISIS RADIAL Y CUBITAL

- Tratamiento quirúrgico: osteosíntesis de ambas diáfisis con placa y tornillos



LESIÓN DE MONTEGGIA

Fractura de diáfisis cubital + luxación de la cabeza del radio (RCP)

Tratamiento

- Reducción de la diáfisis cubital
- Osteosíntesis con placas y tornillos
- La luxación se reduce espontáneamente

Complicación: lesión de nervio interóseo posterior, rama del nervio radial.



LESIÓN DE GALEAZZI

Fractura de diáfisis radial + luxación de la cabeza del cúbito (RCD)

Tratamiento

- Reducción de la diáfisis radial
- Osteosíntesis con placas y tornillos
- La luxación se reduce espontáneamente



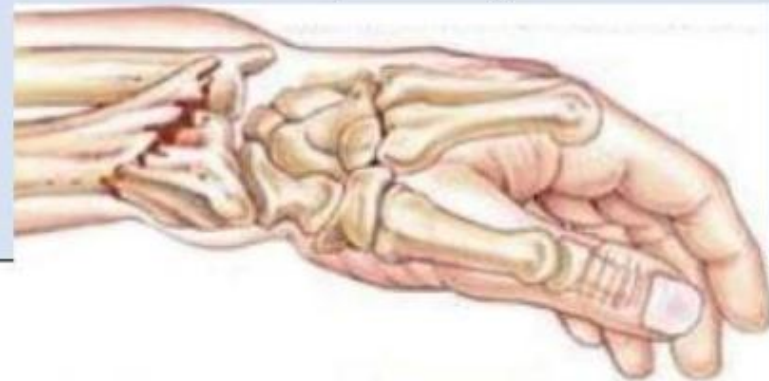
FRACTURA DE COLLES (más frecuente)

- Por caída en extensión
- Desplazamiento dorsal
- Deformidad en "dorso de tenedor"



FRACTURA DE SMITH (COLLES INVERTIDO)

- Por caída en flexión
- Desplazamiento ventral
- Deformidad en "pala de jardinero"



- INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN PACIENTES CON FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR
- En las ocupaciones cotidianas nos relacionamos constantemente con el ambiente físico y social, en el cual nos enfrentamos a la acción de diversos agentes físicos tales como el calor, electricidad, fuerzas mecánicas entre otras, que pueden ocasionar algún daño en nuestro esqueleto óseo.
- Como sabemos, las fracturas se clasifican según diversos criterios, de acuerdo a ellos y a las condiciones particulares de la lesión se realizan intervenciones médicas a nivel ortopédico o quirúrgico.
- En los servicios de terapia ocupacional se reciben pacientes con fracturas de miembro superior e inferior, a quienes se les interviene de acuerdo a criterios como tipo de fractura, tiempo de evolución, alteraciones asociadas, evolución del proceso de consolidación, complicaciones en el proceso entre otras. Los pacientes con este tipo de lesiones presentan alteración esencialmente del componente motor.

ASPECTOS A EVALUAR	INSTRUMENTOS
Rango de movimiento articular (pasivo, activo)	Goniómetro, electrogoniómetro, fluido goniómetro.
Fuerza muscular	Test musculares, pinzómetros.
Dolor	Escala análoga del dolor EVA
Edema	Huíncha de medir, desplazamiento hídrico
Resistencia	Actividad con fuerza mantenida o ejercicios repetitivos hasta el punto de fatiga, Debe ser una actividad medida en tiempo y repeticiones.
Sensibilidad	Test de discriminación de 2 ptos, instrumentos calibrados y precisos, exposición a temperatura, dolor, presión y tacto.

- ## Intervención

- La intervención del terapeuta ocupacional en los pacientes fracturados incluye en términos generales los siguientes aspectos.
- -Reducción o control del edema, mediante vendajes , elevación del miembro afectado, movimiento activo y otras técnicas.
- -Estabilización del segmento, mediante el uso de soporte ortésico.
- -Mantención o aumento de rangos de movimiento articular, fuerza, resistencia. Todos estos aspectos pueden trabajarse mediante ejercicios con implementos, ergoterapias, otras actividades terapéuticas, basados en los principios propuestos por el modelo biomecánico.
- -Mantención o aumento de la función global del miembro superior con énfasis en mano.
- -Control o disminución del dolor, mediante técnicas de relajación y estabilización mediante el uso ortésico.
- -Mantención o mejoramiento de habilidades motoras para el desempeño en AVD y el retorno al trabajo, mediante entrenamiento específico, adaptación a la actividad, evaluaciones de puesto de trabajo entre otras.
- Lesiones de mayor interés para terapia ocupacional



Rehabilitación de la mano

Terapia ocupacional

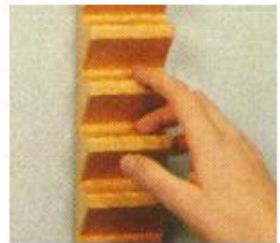
- ◆ Entrenamiento en las AVD
- ◆ Diseño, adaptación y aprendizaje del uso de ayudas técnicas
- ◆ Entrenamiento de la discriminación perceptiva
- ◆ Orientación en ocio y trabajo
- ◆ Técnica de aplicación:
 - ◆ Adquirir la confianza del paciente
 - ◆ Comenzar por lo que ya puede hacer
 - ◆ Exigir cada vez más (sin grandes esfuerzos)
 - ◆ Intentar que incorpore los logros obtenidos



•Tipologías para psicomotricidad



Digiflex: desarrolla fuerza y disociación



Escalerilla: desarrolla disociación y alcance vertical



Torres: Para pinzas, precisión



Mosaico: para pinzas, precisión.

•Tipologías para sensibilidad



Bola poliuretano: para fuerza. Hay de varias resistencias.



Estropajos: Para normalizar la sensibilidad mediante frotación.

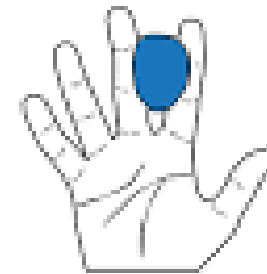


Cepillos: para normalizar la sensibilidad mediante frotación.

•Tipologías para percepción



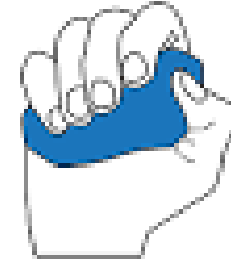
Tarros de igual apariencia rellenos con pesos diferentes: para tratamiento de barognocia



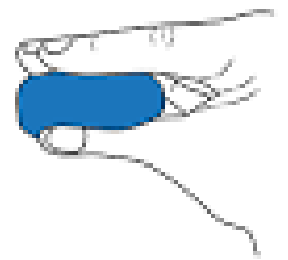
Tijeras de dedos



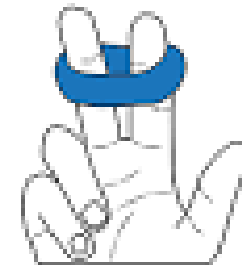
Pellizco



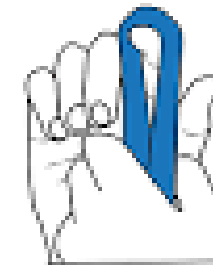
Agarre de fuerza



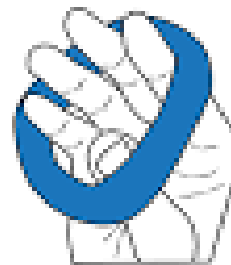
Pellizco plano



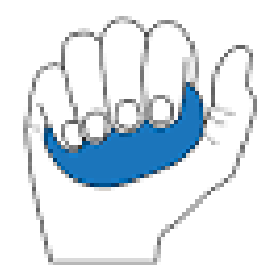
Separación de dedos



Extensión de dedo



Extensión de puño



Agarre completo

- CASO CLÍNICO
- Mujer de 40 años, casada, madre de tres hijos pequeños (12, 9 y 4 años), vive con su marido e hijos. Es dueña de casa, diestra.
- Fractura subcapital de húmero izquierdo con disminución notable de rango de movimiento en abducción, flexión anterior y posterior, rotaciones internas y externas, disminución de potencia muscular flexora y abductora

- Objetivos:
- -Aumentar rangos de movimientos de flexión anterior y posterior, abducción y rotaciones de hombro
- -Aumentar fuerza muscular en movimientos de hombro (flexión, abd y rotaciones)
- Actividades
- -Ejercicios activos con escalera de dedos. El ejercicio se realizará de dos formas:
- 1) La paciente se pondrá de frente a la escaleras de dedos que se encuentra en la pared y realizando flexión de hombro subirá lo que más pueda.
- 2) La paciente se dispondrá de lado a la escalera de dedos y realizando abducción de hombro subirá lo que más pueda.
- -Ejercicios resistidos en escalera de dedos. Se realizarán los mismos ejercicios descritos anteriormente pero ahora con pesas en la zona distal del húmero para aumentar fuerza.
- -Ejercicios para rotaciones de hombro (activo y resistido)
- 1) Armar una torre con legos gigantes. Con el hombro pegado al cuerpo y el codo en flexión, la paciente realizará rotación externa y tomará los legos que se encuentran en una mesa dispuesta al lado izquierdo de ella, los llevará uno a uno a la mesa que se encuentra en frente, realizando rotación interna, y realizará la torre con los legos.
- 2) En un cajón con arena se esconden distintos elementos. La paciente, realizando rotaciones de hombro (con codo flectado entre 70° y 90°) deberá buscar en el interior de éste los elementos. A medida que transcurra el tratamiento se echará más arena al cajón para aumentar la resistencia.

Presente.